



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : سلوي ابراهيم عبده فايد
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : عين شمس
العنوان : --
رقم البطاقة : 27410301401502 رقم التليفون : 01228113604
تاريخ تسجيل الإستمارة : 06-10-2026
العمر (تاريخ الميلاد) : 30-10-1974 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط اول تاموكسيفين
قسم العلاج :
الاورام

[14160]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سلوي ابراهيم عبده فايد National ID: 27410301401502	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Tamoxifen therapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
وزارة الداخلية

جنس
الراحم عبد قاي

٢٠١٣
شبرا الخيمة أول - الثانية

٢٧٤١٠٣٠١٤٠١٥٠٢

KY3392089



٢٠٢٥/٠١ ٢٧٤١٠٣٠١٤٠١٥٠٢

ر.ه سن

٢٠٢٥/٠١

٢٠٢٥/٠١



١١



Patient Name : الأبنات / مروة إبراهيم عبد

Patient No. : 27410301401502

Path No. : 275/24

Sex : Female

Age : 49 Y

Referring Doc :

Request No. : 13000638

Request Date : 20/01/2024

Verification Date : 05/02/2024

Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام

Department : Out Patient

Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

- RCB: 3.56, RCB class III :

Signature

Prof. Dr.Gamal Abdelatty.

Dr.Marwa Mahmoud.

Dr. Rana Fathy.

Verified by :



Name: سلوى ابراهيم عبده		
MR. : 5835		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient is a 50-year-old individual who underwent neoadjuvant chemotherapy for luminal breast cancer, followed by breast conserving surgery and a radiation port. Post-operative management included tamoxifen for adjuvant therapy with the intention of achieving an annual assessment of disease status. Recent imaging with CT of the chest and a transvaginal ultrasound revealed a 6 mm endometrial thickness with no evidence of residual disease. The patient is continuing tamoxifen therapy with supportive care and is scheduled for a follow-up visit in three months.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	20-09-2026
	الوقت :	اسماء محمد مصطفى نصر
الطبيب المعالج :		
يعتمد ,		

Patient Name : الأستاذ / ماسوى ابراهيم حيد	Request No. : 13000638
Patient No. : 27410301401502	Request Date : 20/01/2024
Path No. : 275/24	Verification Date : 05/02/2024
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - فئة الدولة
Age : 49 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer, post NACT.

Nature Specimen: Right breast conservative surgery and Axillary lymph node dissection.

Gross Examination:

- * Procedure: Right BCS
- Fibrofatty tissue piece measured 6x4x1.5 cm with covering skin ellipse measured 5x1.5 cm.
- * Tumor extent: A wired greyish white tumor bed site
- * Size: 2.2x1x0.7 cm.
- * Distance from margins: 0.3 cm away from (superior margin)
- * Axilla : Fibrofatty tissue peice measured 10x7 cm entangling 13 LN up to 4x1.8 cm.

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma (Cellularity 50%)
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): Grade (3+2+1) II.
- * Actual tumor size : 2.2x1x0.7 cm.
- * Ductal carcinoma in situ: Focal (10%).
- * Skin Involvement: Free.
- * Resection margins: Free.
- * Histologic response to therapy: Partial pathological response.
- * Lymph nodes : Positive (2/13).

Diagnosis:

Right BCS, post NACT:
Invasive duct carcinoma Grade II with focal DCIS.
Free margins.
Partial pathological response.
Positive lymph nodes 2/13.
Stage: ypT2, ypN1

Verified by :





Patient Name: Salwa Ibrahim Abdou Fayed	Date : 22/06/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 48 Year(s)
Medical ID: 2299/2023	Pat. ID: 39496

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

A reported case of right breast cancer (newly discovered)

I Chest:-

- Few enlarged right axillary lymph nodes (level I). The largest measuring 21 x 23 mm having globular shape.
- Bilateral tiny pleural tags and apical atelectatic bands.
- Tiny pulmonary nodules is seen at left lower lung lobe measuring 3mm likley nonspecific.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Tiny right renal middle calyceal stone is noted measures 2 mm. Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no left renal stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- IUD is noted in place.
- The scanned skeleton show D7 sclerotic lesion, likley bone island.

NAME: salwa ibraheim abdom
DATE:28/6/2026

Trans-vaginal ultrasound scanning revealed: -

○ **Uterus: -**

- AVF, average size uterus measuring about: 8x4x4cm in its longitudinal, transverse & AP diameters respectively.
- The myometrium shows homogenous texture with no focal lesion
- The endometrial line is 6mm.
- The cervix is of average size showing multiple Nabothian cysts.

○ **Ovaries: -**

- Both ovaries are average size with no focal lesions
- No free fluid in the Douglas pouch.

Conclusion:

Unremarkable study

Dr. NERMEEN RAMADAN FEBR, MD

Patient's Name: Salwa Ibrahim Abdu
Date: 2026-06-25
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

**MULTISLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:**

I- CHEST:

- Few scattered bilateral atelectatic bands
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

Opinion:

❖ **No hepatic or pulmonary metastatic lesions.**

Dr.Asser Ahmed

Patient's Name: Salwa Ibrahim Abdu

Date: 2026-06-25

Referred by: Prof.Dr. no doctor

Hospital: Goustave Roussey International Egypt

جوستاف
رؤسسي
مصر

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast

sonography revealed:

Clinical summary: Status post right CBS & ALAND, followed by radio therapy, routine follow up study.

Findings:

Right breast

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- Thickened skin and coarsen trabeculae.
- LOQ, posterior third, architectural distortion with no speculations, masses, asymmetry, or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated LOQ, posterior third, area of parenchymal disruption underneath the operative scar with no solid, cystic lesions or fluid collections.
- Thickened skin and coarsen trabeculae.
- Clear right axilla. No pathological infra or supra-clavicular lymph nodes

Left breast

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin, nipple/areola.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion: -

Right breast (BIRADS 2): Post-Therapeutic sequelae.

Left breast (BIRADS 1): Normal study

Recommendation: -

For annual follow up.

Best Regards,

DR. Amal Hegazi, M.Sc.

BIRADS classification of breast lesions according to the American College of Radiology used for breast assessment combined with recommendations:

Category & recommendations

BIRADS 0: Non-informative study.

BIRADS 1: Normal study, routine screening

BIRADS 2: Benign findings, routine screening

BIRADS 3: Probably benign, for close follow up.

Suspected Cancer Risk

0 %

0 %

2 %